

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小兒腸胃炎 Pediatric Gastroenteritis				
編號	A31000-Q03-W-N20	制定者	R10 陳倩芳	公布日期	102 年 03 月 28 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 1.7 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解小兒腸胃炎的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題、措施及衛教指導，使護理人員有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部兒科單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

腸胃炎係指胃、小腸或大腸的發炎，會導致病患嘔吐或腹瀉。好發於嬰幼兒，以病毒及細菌為主。輪狀病毒可發生在新生兒期，易在上段空腸造成傷害，好發於冬天，同時會引起上呼吸道感染。細菌細腸炎如沙門氏菌，常於迴腸尾端及大腸造成傷害，會排出帶血便及分泌性下痢，脂肪吸收不良。志賀氏桿菌則會造成腹部痙攣，排出帶血便。另有曲狀桿菌、大腸桿菌、鏈球菌等菌。

（二）症狀

1. 腹瀉、脫水：是腸胃炎最主要的症狀，排便次數增加、性質改變。
嚴重腹瀉會導致脫水，甚至休克、死亡。
2. 嘔吐：嚴重嘔吐時，因為胃液大量流失易造成代謝性鹼中毒。
3. 腹部痙攣、腹部觸壓痛。
4. 全身症狀：病童會有發燒、食慾減退、疲倦、不安、嗜睡等情形。
5. 皮膚破損：頻繁的腹瀉刺激肛門及周圍皮膚，造成皮膚發生破損。

主題名稱	小兒腸胃炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N20	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	2/6

(三) 常見檢查

1. 血液檢查：血比容(Hct)、(Hb)值升高、血清鈉、鉀下降、pH 值下降。
2. 尿液分析：尿量減少、尿比重上升（正常為 1.003-1.010）。
3. 糞便培養：PH 值減少顯示糞便中的脂肪量多，PH 值增加表示蛋白質分解量多；檢體中發現寄生蟲及蟲卵，可確認為寄生蟲感染。糞便培養可確定感染的致病菌，採用適當的藥物。
4. 大便 pH 值：降低-表示酸性大便，增加-表示蛋白質之分解量增加。

(四) 常見治療

1. 支持療法：禁食 12-24 小時，以減緩腸蠕動，並讓腸道休息，採少量多餐給予口服葡萄糖電解質口服液或清流質飲食。大部分腸胃炎由病毒引起，除非已知為特定細菌感染，否則不需抗生素治療。
2. 限制乳糖的攝取：腸黏膜受刺激及傷害後，腸道內乳糖酶會有一段時間缺乏或功能不足的情形，此時宜先以半奶或去乳糖配方奶餵食，或以其他食物替代。
3. 腸蠕動抑制劑：K.B.T 複方止瀉劑。Imodium 嚴重腹瀉時可使用，但藥物會造成腸蠕動減慢或腸道阻塞，嬰幼兒急性感染性腹瀉並不建議服用止瀉劑。
4. 脫水的治療：經由靜脈注射補充體液及電解質。

(五) 護理問題

1. 易肺吸入／與嘔吐有關。
2. 發燒／與腸道感染有關。
3. 皮膚狀態不完整／肛門及周圍皮膚受排泄物刺激有關。

(六) 護理措施

1. 易肺吸入／與嘔吐有關。
 - (1) 評估病人咀嚼吞嚥的能力。
 - (2) 瞭解病人吞嚥困難的原因，協助醫師治療。
 - (3) 進食時病人應採取坐姿。
 - (4) 食物應易於咀嚼和吞嚥，例如：軟質食物或細緻食物。

主題名稱	小兒腸胃炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N20	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	3/6

(5) 採少量多餐進食，減少疲倦。

(6) 應讓病人有充分時間進食。

(7) 病人進食時應有人在旁陪伴且護理人員應親自或教導家屬注意肺吸入症狀。

(8) 抽吸用物應準備在床旁。

(9) 情況未改善，必要時依醫囑，改由鼻胃管灌食，以降低肺吸入的危險性。

2. 發燒／與腸道感染有關。

(1) 每 30 分鐘測量生命徵象至穩定並記錄。

(2) 依醫囑給予靜脈點滴輸液。

(3) 依醫囑給予抗生素注射。

3. 皮膚狀態不完整／肛門及周圍皮膚受排泄物刺激有關。

(1) 每班評估皮膚受損情形，並作紀錄。

(2) 調整個案的臥姿，避免長時間仰臥壓迫臀部。

(3) 保持皮膚的清潔乾燥。

(4) 避免過度刺激肛門，病童排便後給予溫水及中性肥皂清潔局部，勿用具刺激性的溼紙巾擦拭。

(5) 勤換尿布。

(6) 若紅臀厲害，將臀部適度暴露，並以烤燈 25-40 瓦特，保持在 30-40 公分之距離，使用不超過 20 分鐘。

(7) 提供適當的營養，促進組織的復原。

(8) 依醫囑給予紅臀藥膏使用。

(七) 衛教指導

1. 採少量多餐、溫和且無刺激性的食物（少油、少調味、低蛋白），如粥、白饅頭。

2. 食物的攝取採漸進式之飲食方式，飲食量由少漸增。

3. 腹瀉超過一週或嚴重腹瀉的，建議改用不含乳糖配方的止瀉奶粉。

4. 應加強洗手，尤其是進食前後、更換尿布前後、與動物接觸後均應仔細的用肥皂洗淨雙手。

主題名稱	小兒腸胃炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N20	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	4/6

5. 選擇透氣尿布並常更換，以預防尿布疹，並隨時保持臀部清潔、乾燥，每次排便後可以溫水輕拭臀部。
6. 注意食物的清潔及奶瓶消毒，避免進食不潔及不新鮮的食物。
7. 給予充足的水份攝取，以預防脫水。
8. 減少曝露於已罹患腸胃炎個案的環境中，尤其是在傳染期。
9. 本院可使用衛教單 T-ped-021 兒童腸胃炎。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 黃立琪(2021)・兒童消化系統疾病及其護理・於陳月枝總校閱，*實用兒科護理*（九版，521-539 頁），華杏。
- (二) 蔣立琦、蔡綠蓉、黃靜微、邱淑如、毛新春、吳書雅...吳佩玲(2023)・兒童消化系統疾病與護理・於黃美智、蔣立琦總校閱，*兒科護理學*（最新修訂版，655-661 頁），永大。

七、附件

(略)

主題名稱	小兒腸胃炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N20	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.03.28	1.0	新制定。	102 年 03 月 28 日護理部照護標準委員會通過；102 年 03 月 28 日公布。
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	1.1	新增說明(七)9.本院可使用衛教單 T-ped-021 兒童腸胃炎。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.08.31	1.2	更新第六項參考文獻資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	1.3	1.第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	1.4	修訂第六項參考文獻資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	1.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第六目之 2(8)修訂水溫。 3. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 4. 更新第六項參考文獻資料	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	1.6	1. 更新第三項第五目護理問題及第六目護理措施。 2. 更新第六項文獻參考資料。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。

